

1 骨髄抑制の薬薬連携 — nadir期の発熱に備える

病院薬剤師	病院と共有する情報	保険薬局薬剤師
① レジメンのFNリスク評価とG-CSF一次予防の設定	投与日・nadir期 (電話フォローの時期)	① nadir期に合わせた電話フォロー(発熱・感染徴候)
② 投与前の血液検査で投与可否・減量を判断	好中球数・血小板数 (処方箋の検査値)	② 手持ちの抗菌薬の服用開始条件と連絡方法の説明
③ FN発症時の抗菌薬選択と院内対応	手持ちの抗菌薬 (開始条件)	③ G-CSF後の骨痛への対応(体温を測ってから鎮痛薬)
④ 手持ちの抗菌薬の処方設計と説明	予防投与 (ST合剤・抗ウイルス薬)	④ ST合剤・抗ウイルス薬など予防投与の継続確認
⑤ FN発症・減量の経緯を薬局へ情報提供		⑤ 発熱時の受診先と夜間・休日の連絡先を事前に確認

2 FNのリスク評価とG-CSF・抗菌薬の使い方

FN発症率20%以上のレジメン	FN発症率10～20%のレジメン	前コースでFNを起こした
対応の基本 G-CSFの一次予防を推奨 薬剤師の確認ポイント ベグフィルグラスチムは化学療法終了の翌日以降に投与(同日は避ける)	対応の基本 リスク因子(65歳以上・全身状態不良・FNの既往等)で判断 薬剤師の確認ポイント リスク因子を薬歴に記録し、処方医と共有	対応の基本 二次予防(G-CSF)または減量・延期 薬剤師の確認ポイント 前回の発熱・入院の経緯を薬歴に記録
FN発症時:低リスク(MASCCスコア21点以上)	FN発症時:高リスク	
対応の基本 外来で経口抗菌薬(例:レボフロキサシン+アモキシシリン・クラブラン酸) 薬剤師の確認ポイント 手持ちの抗菌薬の服用開始の条件と連絡方法を説明	対応の基本 入院のうえ広域の静注抗菌薬(例:セフェム等) 薬剤師の確認ポイント 至急の受診を勧める	

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サプリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
注意 添付文書 併用注意	メトレキサート 薬酸代謝阻害の重複・排泄遅延	処方薬 ST合剤	骨髄抑制↑	他院のST合剤の処方を確認
注意 添付文書 併用注意	パルボシクリブ等 CYP3A4阻害	処方薬 クラリスロマイシン・アゾール系抗真菌薬	血中濃度↑→好中球減少↑	他院の抗菌薬・抗真菌薬を確認
注意 添付文書 用法・用量	FTD/TPI 空腹時は吸収が増加	生活習慣 空腹時の服用	好中球減少が増強	朝夕の食後に服用するよう指導
注意 添付文書 用法・用量	レナリドミド 腎排泄の低下	既往・疾患 腎機能の低下	血中濃度↑→骨髄抑制↑	CCrに応じた用量を確認
注意 添付文書 併用注意	レボフロキサシン(手持ちの抗菌薬) キレート形成	処方薬 市販薬 Mg・Al含有の制酸剤・鉄剤	吸収↓→効果減弱	服用時間をずらすよう指導
確認 服薬指導上の注意	化学療法中の・患者 発熱を隠す	市販薬 市販の解熱鎮痛薬・かぜ薬	FNの発見の遅れ	服用前に体温を測り、発熱時は連絡

4 服薬指導タイムライン(声かけ例)

① 治療開始前	② 投与後～1週	③ 投与後1～2週	④ 次回来局時
“ 治療後1～2週は、体を守る白血球が最も減る時期です。体温を毎日測る習慣をつけましょう ”	“ 生ものを控え、手洗い・うがいを。ベグフィルグラスチムの後は骨や腰が痛むことがあります ”	“ 37.5℃以上の熱が出たら、解熱剤で様子を見ずに、すぐ病院へ連絡してください ”	“ 前回の治療のあと、熱や出血、息切れはありませんでしたか ”
✓ 薬局で確認 お薬手帳でレジメン・投与日、G-CSFの予定、手持ちの抗菌薬の有無	✓ 薬局で確認 G-CSF後の骨痛と鎮痛薬の使い方、感染予防の実践	✓ 薬局で確認 電話フォローで発熱・悪寒・のどの痛み・排尿時痛を確認	✓ 薬局で確認 検査値の推移、発熱・出血・貧血の症状
△ ここに注意 夜間・休日の連絡先を事前に共有	△ ここに注意 痛み止めを飲む前に体温を測る習慣を	△ ここに注意 発熱・悪寒はFNを疑い夜間休日でも受診	△ ここに注意 FNや減量の経緯はトレーシングレポートで共有